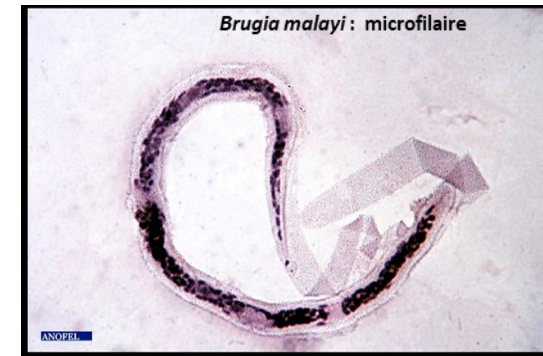




Université de Constantine 3 Saleh Boubnider
Faculté de Médecine
Département de Médecine



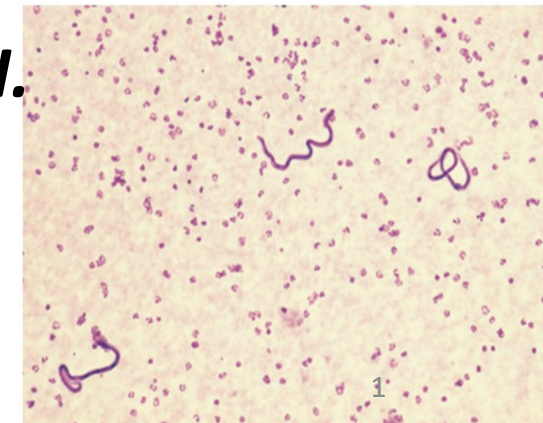
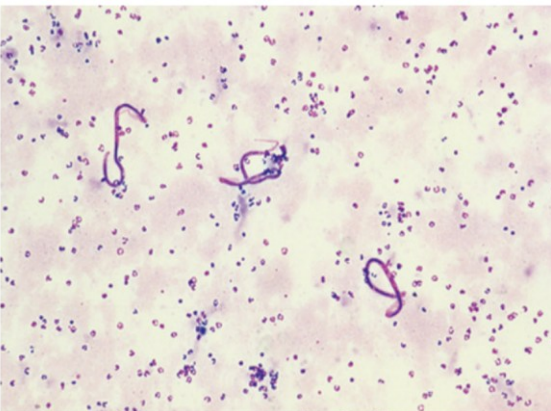
FILAIRES ET FILARIOSES

Élaboré par:

Dr Belattar.N

Dr. Benlaribi I. H.

Année universitaire 2025/2026



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- **Différencier** les filaires pathogènes des filaires non pathogènes.
- **Evoquer** le diagnostic d'une filariose devant des signes cliniques et biologiques évocateurs.
- **Planifier** une prise en charge thérapeutique adéquate.
- **Proposer** des mesures préventives adaptées.

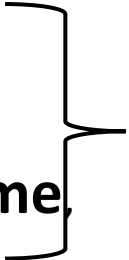
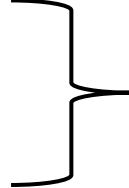
PLAN

- I. Généralités.**
- II. Classification**
- III. Filarioses lymphatiques**
- IV. Onchocercose**
- V. Loase**

GÉNÉRALITÉS

- Les filarioses sont des helminthiases largement répandues, transmises souvent par des **arthropodes (insecte): maladie vectorielle**.
- Elles font partie des **grandes endémies tropicales** avec plus de **400 millions** personnes infectées dans les régions **tropicales et subtropicales**.

GÉNÉRALITÉS

- Elles sont dues à des nématodes filiformes et vivipares vivant dans :
 - le système **lymphatique**,
 - le **tissu sous-cutané** ou
 - les **cavités séreuses de l'organisme**,**les filaires: adultes**
- Les larves émises par la femelles, rencontrées dans:
 - le **sang (sanguicole)**
 - les **tissus (Peau, œil)****les microfilaires.**
- Ces nématodoses se traduisent par des tableaux cliniques variables.

GÉNÉRALITÉS

❑ **Neuf (09) espèces** décrites chez l'Homme se répartissent selon leur impact en santé publique en:

- Filarioses **majeures** (pathogènes) :
 - Filarioses lymphatiques
 - Filarioses cutanéodermiques : **Loase ; Onchocercose; filariose de Médine**
- Filarioses **mineures** (peu ou pas pathogènes).
 - Mansonelloses
 - Dirofilarioses

GÉNÉRALITÉS

❑ On distingue selon la topographie des adultes:

- Filarioses lymphatiques : **Wuchérériose ; Brugiose.**
 - Filarioses cutanéodermiques : **Loase ; Onchocercose; filariose de Médine**
Mansonelloses à *M streptocerca*
 - Autres: **Mansonelloses (à *M ozzardi* et *M perstans*)**
Dirofilarioses (Filarioses animales en impasse chez l'homme)
- Filarioses majeures**
- Filarioses des C.séreuses**
- Filarioses mineures**

NB: La **filariose de Médine** ou **dracunculose**, malgré son nom, ne fait pas partie de la famille des filaires stricto sensu + en voie d'éradication 14 cas en 2024 selon l'OMS

CLASSIFICATION

- **E:** *Helminthes*
- **S/E:** *Nemathelminthes*
- **C:** *Nematodes*
- **O:** *Spirurida*
- **Super F:** *Filarioïdés*
- **F:** *Filaridés* F: *Onchocercidae*
- **G:** *Wuchereria, Brugia.* G: *Onchocerca*
Loa
- **Espèces:** *W. bancrofti* et sa variété *pacifica* . *Onchocerca volvulus*
 B. malayi (ou filaire de Malaisie) *Loa loa*
 B. timori.

Filarioses lymphatiques

DEFINITION

Les **filarioses lymphatiques** sont:

- des nématodoses **strictement tropicales**.
- engendrées par la présence dans les voies lymphatiques, de 3 espèces de filaires : *Wuchereria bancrofti* et sa variété *pacifica*, *Brugia malayi* et *Brugia timori*.
- transmises par des moustiques *Culicidae* appartenant aux genres : *Culex*, *Aedes*, *Anophèles* et *Mansonia*.
- Parfois responsables de complications **chroniques** souvent **graves** principalement: les **éléphantiasis**.



ÉPIDÉMIOLOGIE

1- Morphologie:

□ Les adultes:

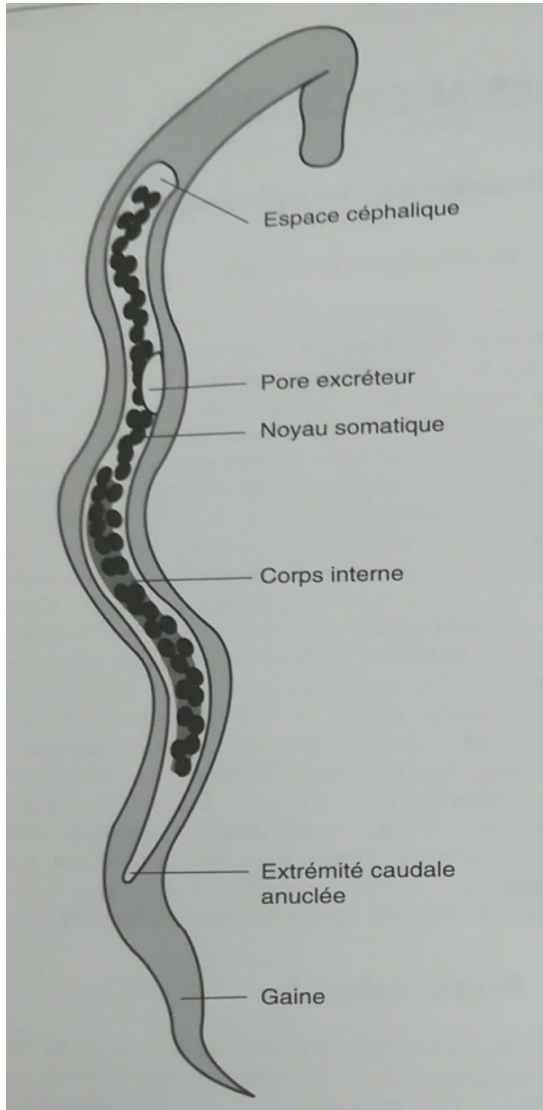
- ✓ Macrofilaires ronds, filiformes, blancs plus au moins translucides.
- ✓ À cuticule lisse, finement striée.
- ✓ L'extrémité caudale arrondie est :
 - rectiligne chez la femelle .
 - recourbée ventralement chez le mâle.
- ✓ L'extrémité antérieure légèrement renflée.
- ✓ Taille: ***W. bancrofti*** est plus grande que ***Brugia sp.***
 - La femelle mesure de **40 à 100** mm de long/**0.2 à 0.3** mm de large.
 - Le mâle mesure **15 à 35** mm de long



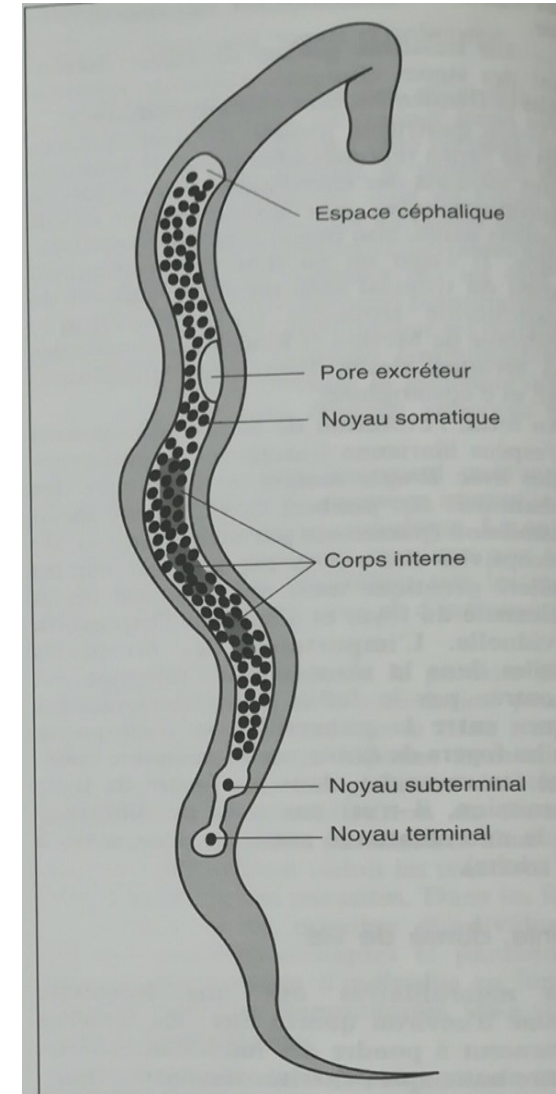
ÉPIDÉMIOLOGIE

□ Les microfilaires:

- Gaine: plus longue que la microfilaire.
- Taille: environ 300 µm
- Extrémité antérieure arrondie et postérieure effilée
- Cuticule striée transversalement.
- Le corps interne est bien visible et coloré en rouge vermillon.



Microfilaire de *Wuchereria bancrofti*



Microfilaire de *Brugia malayi*

ÉPIDÉMIOLOGIE

2-Biologie:

□ Les adultes:

- Localisation: dans **la circulation lymphatique** (vaisseaux et ganglion).
En particulier: canal thoracique, scrotum, cordon spermatique, lymphatiques des membres inférieurs et de l'abdomen...
- Nutrition: **la lymphe** (en relarguant des substances très immunogènes).
- Longévité: importante, **8 à 15** ans dans le système lymphatique de l'homme
- **Vivipares**, les femelles fécondées émettent des microfilaires 2 à 12 mois après l'infestation.

ÉPIDÉMIOLOGIE

□ Les microfilaires:

- Durée de vie dans l'organisme est de quelques mois (***W bancrofti* : 3 à 12 mois**)
- Elles vivent dans la circulation sanguine (sans subir ni mues ni multiplication).
- Uniquement chez le vecteur: transformation des L1 au L2 et L3 (**métacycliques infestantes**).
(Passage nécessaire pour l'évolution au stade adulte → pas de filariose lymphatique transfusionnelle)
- Mobiles (***Wuchereria bancrofti*** est très mobile à l'état frais).
- Les microfilaires: Circulent en permanence dans la lymphe et périodiquement dans le sang.
- Périodicité: Nocturne (Le rythme est parfois subpériodique)

ÉPIDÉMIOLOGIE

- **3- Reservoir:**

C'est principalement l'homme.

- *W. bancrofti*: strictement humaine.
- *B. timori*: homme
- *B. malayi*: homme et nombreux animaux sauvages et domestiques .

ÉPIDÉMIOLOGIE

4- Mode de transmission:

La transmission est assurée par des piqûres répétées de moustiques femelles infectées.

- *W. bancrofti* est transmise par ***Culex, Anopheles et Aedes***.
- L'espèce ***Brugia malayi*** est transmise par ***Anopheles et Mansonia***.
- L'espèce ***Brugia timori*** est transmise par ***Anopheles***.

ÉPIDÉMIOLOGIE



5- Vecteur:

■ Classification:

- **E:** *Arthropodes*
- **C:** *Insectes*
- **O:** *Diptères*
- **F:** *Culicidés*
- **S/F:** *Culicinae, Anophélinæ;*
- **G:** *Culex +++ Anophèles*
Aedes
Monsonia.



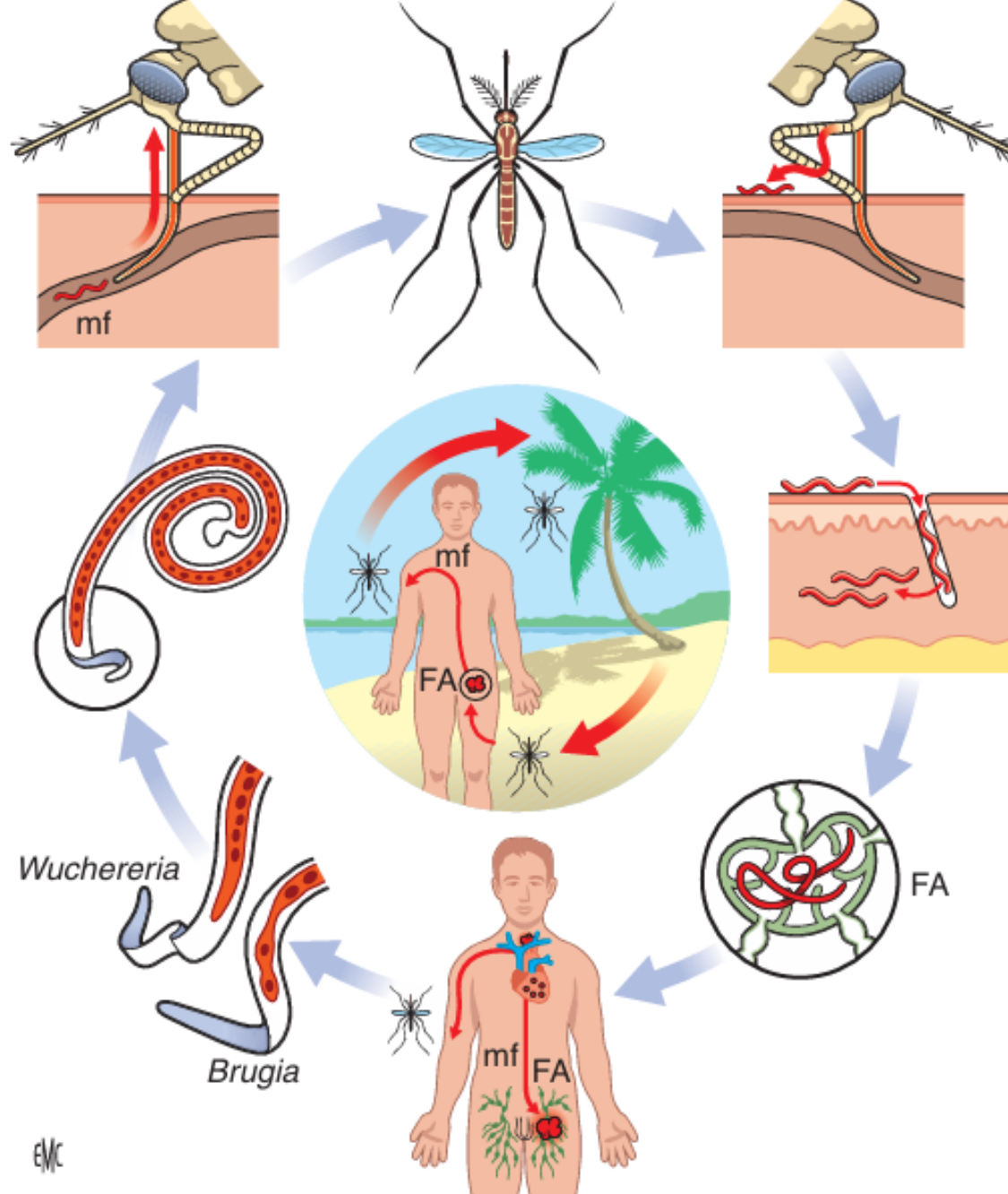
■ Caractères généraux:

- ✓ Diptères, nématocères.
- ✓ Corps élancé, antennes longues, ailes et pattes longues.
- ✓ Larves vermiformes
- ✓ Seules les **femelles** sont **hématophages**

Cycle indirect

Homme: hôte définitif

Moustique: hôte intermédiaire

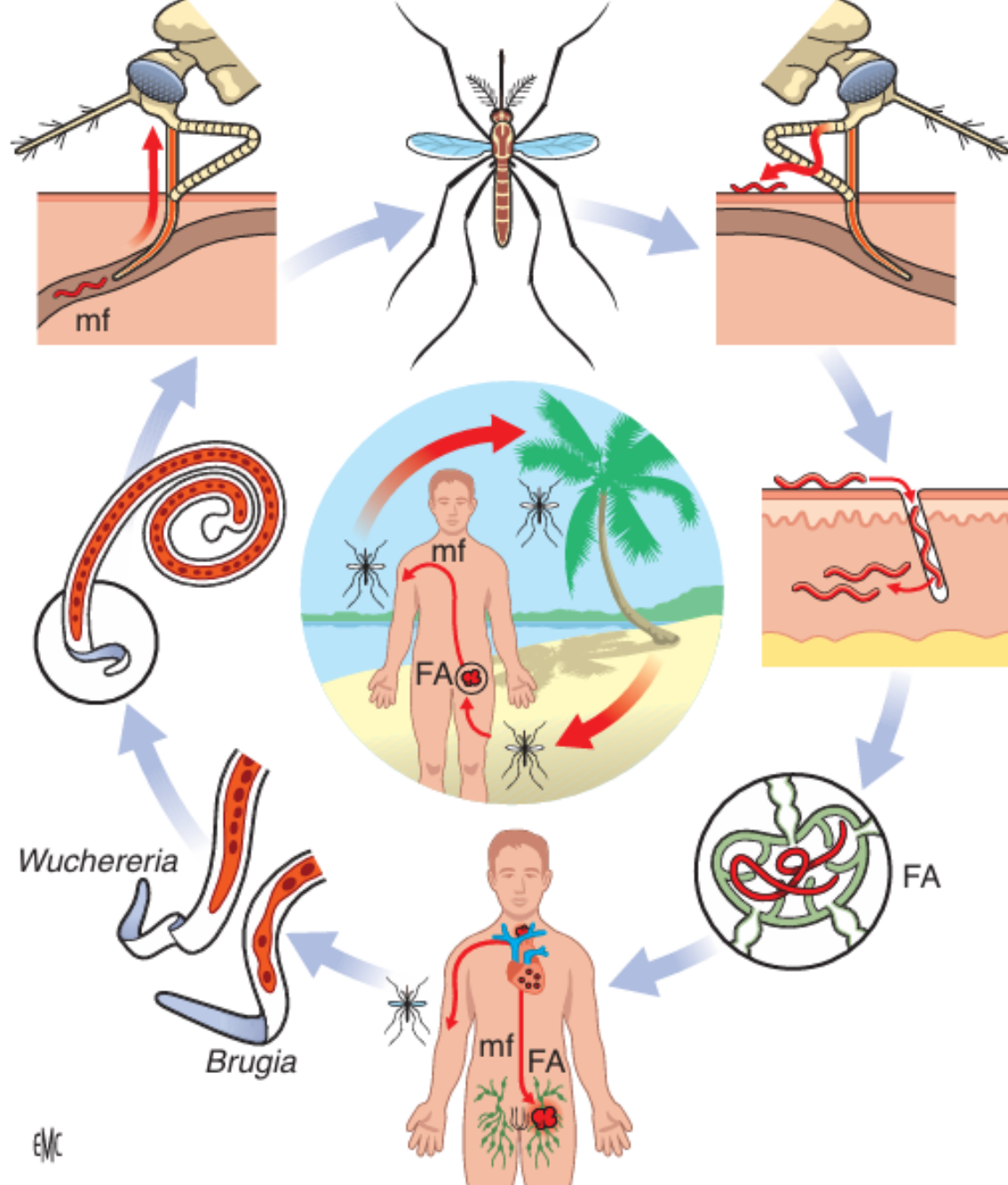


Chez l'insecte:

Lors d'un repas sanguin, les microfilaires sont absorbées par un moustique lors d'un repas sanguin chez un hôte infesté. Elles se développent dans la musculature thoracique en une forme infectante (L1-L3) puis migrent jusqu'à la tête. Durée: 7 à 14 j selon l'espèce et la température

Figure 3. Cycle parasitaire des filarioses lymphatiques. FA: filaires adultes; mf: microfilaires.

Homme: hôte définitif
Moustique: hôte intermédiaire



Chez l'homme:
Lors d'une piqure ultérieure, 1 à 2 larves mobiles tombent et pénètrent la peau au point de pique, atteignant le système lymphatique, elles continuent leur développement pour devenir des vers adultes mâles et femelles.
Après fécondation, la femelle produit jusqu'à **50 000** microfilaires par jour qui passent dans les vaisseaux sanguins.

Figure 3. Cycle parasite des filarioses lymphatiques. FA: filaires adultes; mf: microfilaires.

ÉPIDÉMIOLOGIE

7- Répartition géographique:

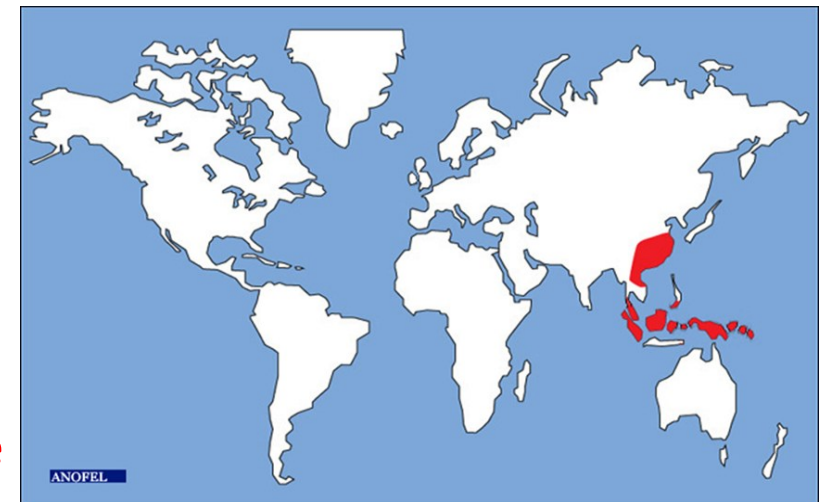
- ***Wuchereria bancrofti*** ou filaire de Bancroft

De loin la plus fréquente (90%), zone intertropicale de l'Amérique, l'Afrique et l'Asie

- La variété ***pacifica*** sévit en Océanie.

- ***Brugia malayi*** ou filaire de Malaisie est exclusivement asiatique

- ***Brugia timori*** ou filaire de Timor présente uniquement en Indonésie



CLINIQUE

1/ formes asymptomatiques:

fréquentes en zone d'endémie avec ou sans microfilarémie

- **Les porteurs sains** de microfilaires sanguicoles constituent le **principal réservoir** de parasites

CLINIQUE

2/ Formes symptomatiques:

Inflammation de la paroi des vaisseaux lymphatiques

Réponse immune exagérée aux **microfilaires piégées dans le tissu pulmonaire**; ++ sujets récemment immigrés en zone d'endémie.

Manifestations aiguës

Adénopathies

Forme allergique « Poumon filarien »

Adénite

Orchite
Épididymite

Lymphangite

Manifestations chroniques

Chylurie

Adénolymphocèle

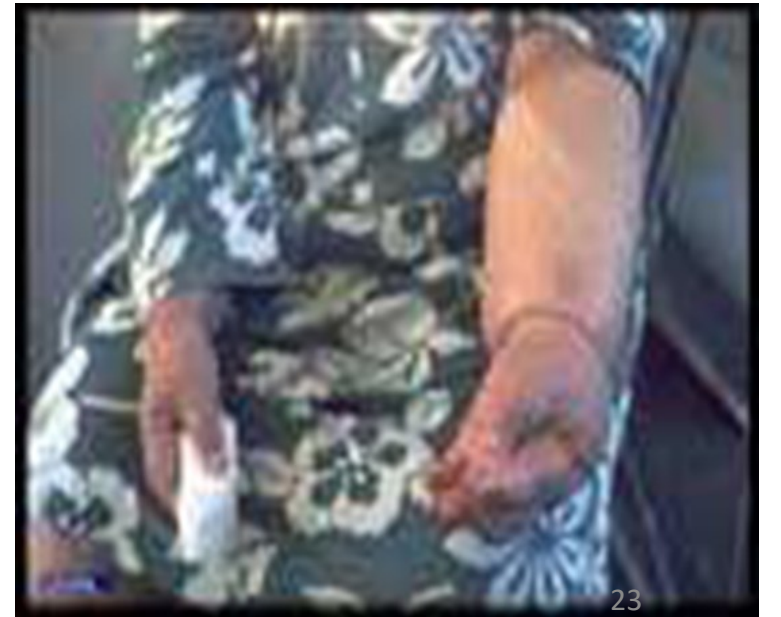
Hydrocèle

Lymphoedème
Éléphantiasis

Obstruction ou dilatation des vaisseaux lymphatiques



Eléphantiasis



DIAGNOSTIC AU LABO

➤ Éléments d'orientation

Le diagnostic d'orientation est basé sur :

- Notion de séjour en région d'endémie
- Présence de lymphangites et d'adénopathies
- Hyperéosinophilie
- Imagerie médicale: permet de visualiser les filaires adultes directement au sein des voies lymphatiques et d'apprécier leurs mouvements, donc leur **viabilité**

DIAGNOSTIC

➤ Diagnostic de certitude

- La recherche des filaires adultes (exceptionnellement retrouvés) est déconseillée car elle fait courir le risque de poussées inflammatoires réactionnelles (ponction ou biopsie ganglionnaires).
- Le diagnostic de certitude est direct et basé sur la recherche quantitative et qualitative des microfilaires dans le sang

La recherche des microfilaires doit tenir compte de leur périodicité. le prélèvement sera effectué
Entre: **22 h-3 h** (+++espèces nocturnes)

DIAGNOSTIC

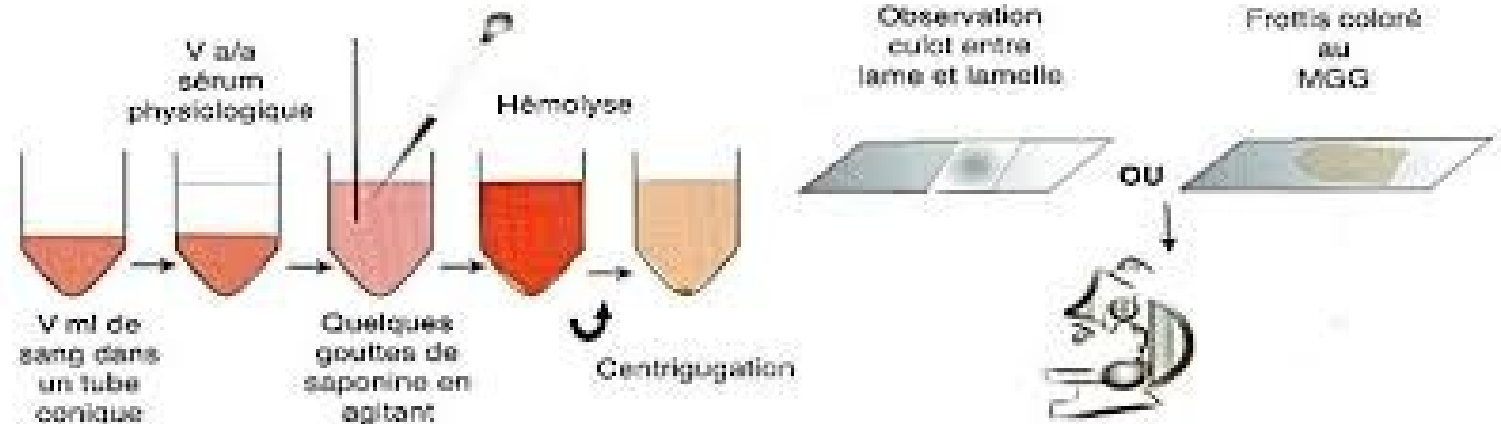
- Examen direct :
 - **l'état frais** (repérage facile: mouvements des microfilaires)
 - **après coloration** sur: Frottis mince /Goutte épaisse: MGG



DIAGNOSTIC

Méthodes de concentration :

- Technique de KNOTT:
- Leucoconcentration à la saponine
- Centrifugation en tubes capillaires



- ❑ Parfois, les microfilaries sont retrouvées dans le sédiment d'une urine chyleuse ou dans le liquide d'hydrocèle.

DIAGNOSTIC

➤ Diagnostic immunologique

- Il est utilisé en cas d'absence de microfilaires et des vers adultes à l'examen direct et surtout au cours des **enquêtes épidémiologiques**
- Les réactions immunologiques sont restreintes vu la rareté des antigènes homologues disponibles et les réactions croisées avec les autres filaires et helminthes :
 - ✓ IFI ++, ELISA, Électrosynérèse
 - ✓ Détection d'Ag circulant / AC monoclonaux;
 - ✓ Test de diagnostic rapide par immuno-chromatographie sur carte utilisant des Ac monoclonaux spécifiques d'Ag de W.b (dépistage en zone d'endémie).

TRAITEMENT

- phase aiguë: traitement **symptomatique** par un **anti inflammatoire** et ensuite **parasitologique** par un **microfilaricides** à dose croissante :

- Diéthylcarbamazine** ou Notezine®

- Ivermectine** ou Mectizan®

- Albendazole** ou Zentel®

- Il est peu efficace contre les filaires adultes.
- Le traitement des lésions tardives est le plus souvent **chirurgical**.

PROPHYLAXIE

- **Collective** :

- Lutte anti vectorielle : insecticides, larvicides, destruction des gîtes larvaires.
- Lutte contre le réservoir du parasite (homme infesté) par chimiothérapie de masse par l'administration annuelle de l'association : **Ivermectine-albendazole**

- **Individuelle** :

- Moustiquaires dans les zones à transmission
- Produits répulsifs
- Port de vêtements protecteurs (longs,...)

Onchocercose (cécité des rivières)

DEFINITION

C'est une filariose **cutanéodermique** due à *Onchocerca volvulus*.

Elle représente la deuxième cause mondiale de **cécité** infectieuse.

La transmission à l'homme se fait par l'intermédiaire d'un insecte vecteur : **une simule**.

Elle concerne environ **21 millions** de personnes (OMS 2024), des zones rurales **d'Afrique subsaharienne (99%)**, du Yémen et d'Amérique latine (1%).

ÉPIDÉMIOLOGIE

2- Morphologie et biologie:

□ Les adultes:

- vers filiformes blanchâtres
- Le mâle: 2-3 cm de long
- La femelle: 30-80 cm de long,
- La durée de vie: 10- 15 ans
- Spécifique à l'homme
- vivent dans le derme (libres ou emprisonnés dans des nodules fibreux (**onchocercomes** ou kystes onchocerquiens)

□ Microfilaires :

300 um de long

gaine absente

Déplacement: dans le derme
(jour et nuit)

Survie: quelques mois



Macrofilaires de l'*Onchocerca volvulus*



Microfilaire de l'*Onchocerca volvulus*

ÉPIDÉMIOLOGIE

3- Vecteur: La simulie

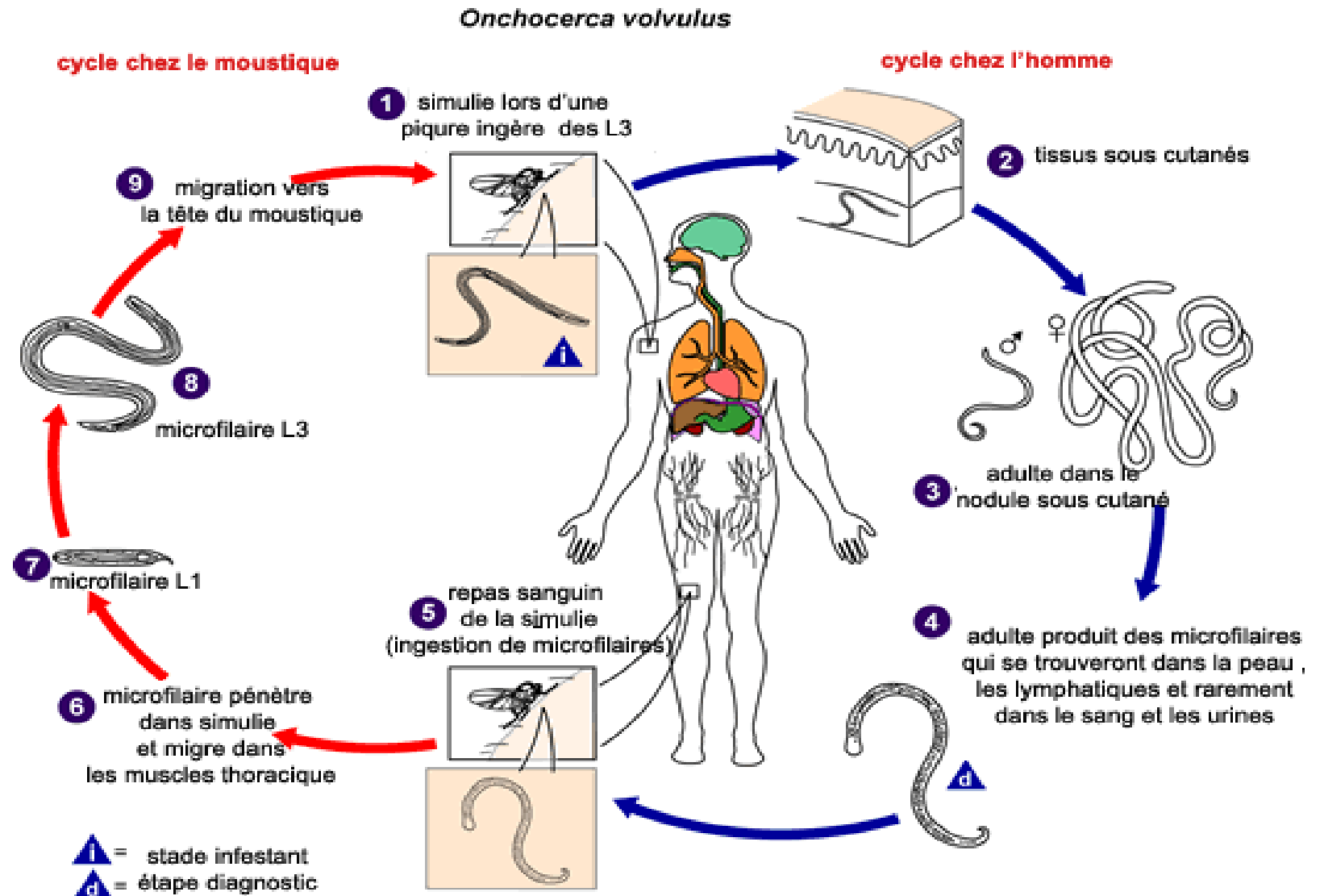
- Diptère nématocère
- Largement répandu dans le monde
- Un petit moucheron noir (1 à 3 mm)
- Reproduction près des rivières et des fleuves tropicaux.
- Seule la femelle est hématophage.
- Activité diurne (Elle pique à l'extérieur des maisons).



- Indirect
- l'homme (hôte définitif)
- la simule femelle (hôte intermédiaire)

Chez le vecteur:

La simule s'infecte lors d'un repas sanguin en prélevant, dans le derme d'un malade, des microfilaries qui évoluent en larve L1, larve L2 dans les muscles thoraciques, puis en larve L3 qui migre vers le tête.

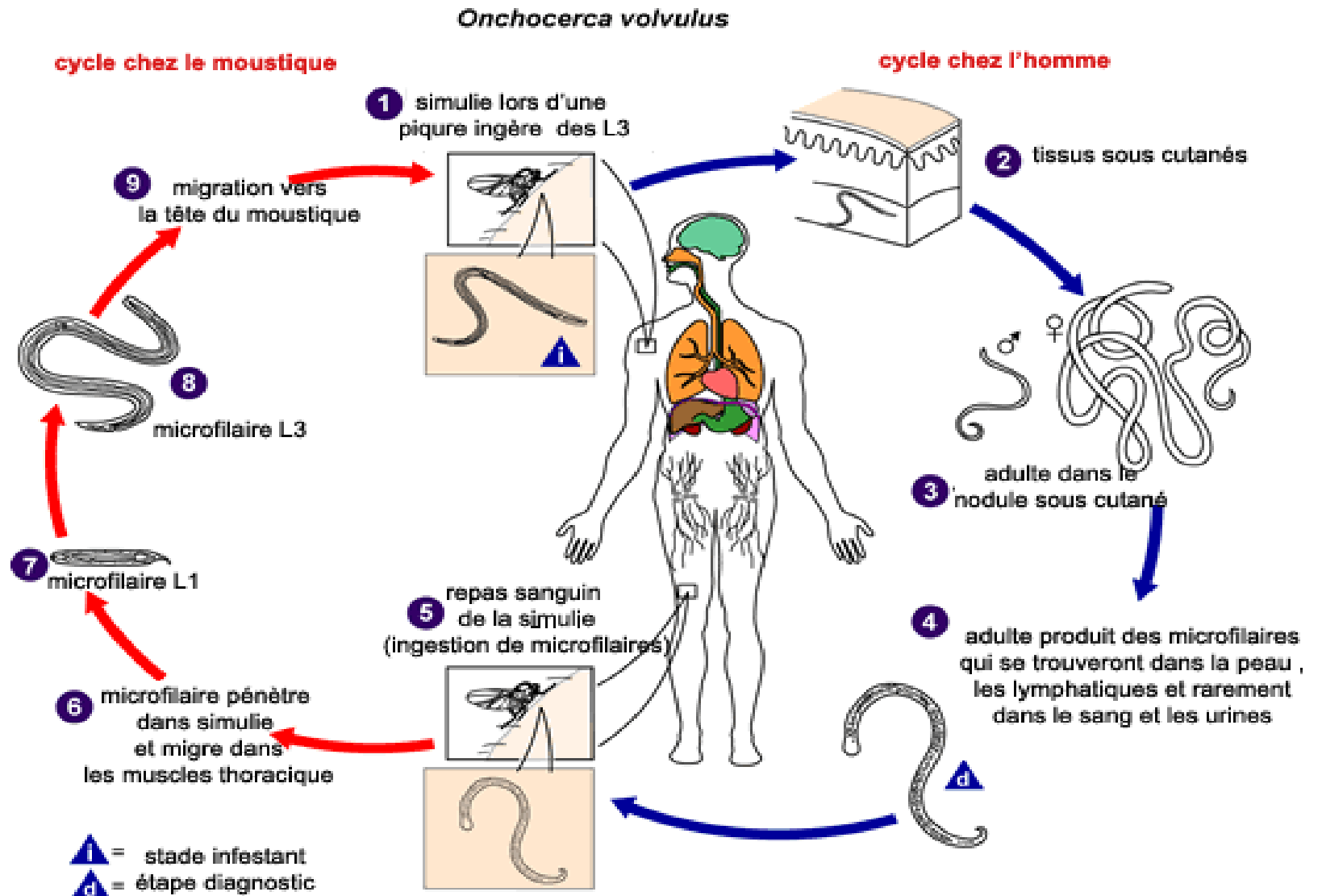


Cycle évolutif d'*Onchocerca volvulus*

- Indirect
- l'homme (hôte définitif)
- la simule femelle (hôte intermédiaire)

Chez l'homme:

Ces larves sont déposées sur la peau d'un sujet et traversent l'épiderme au niveau du point de piqûre. Elles gagnent le tissu conjonctif sous cutané, deviennent adultes et forment des nodules onchocerquiens. Les microfilaries sont libérées de ces nodules et vont migrer dans le tissu sous cutané.

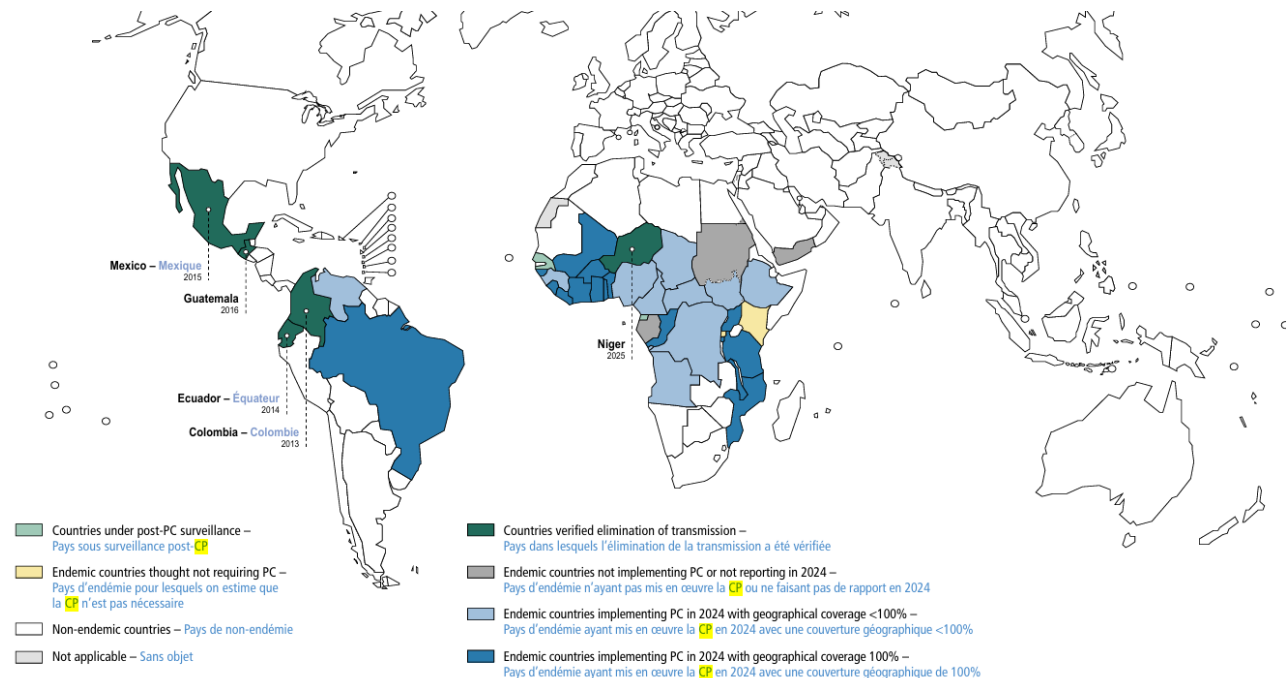


Cycle évolutif d'*Onchocerca volvulus*

ÉPIDÉMIOLOGIE

5- Répartition géographies:

- **Foyer africain** (du Sahel présaharien jusqu'en Angola et la Tanzanie) +++
31 Pays
- **Foyer américain** (Brésil, Venezuela)
- **Foyer asiatique** (Yémen)



CLINIQUE

L'onchocercose souvent asymptomatique ou s'exprime par trois syndromes :

- LE SYNDROME CUTANÉ :



- LE SYNDROME KYSTIQUE :



- LE SYNDROME OCULAIRE :

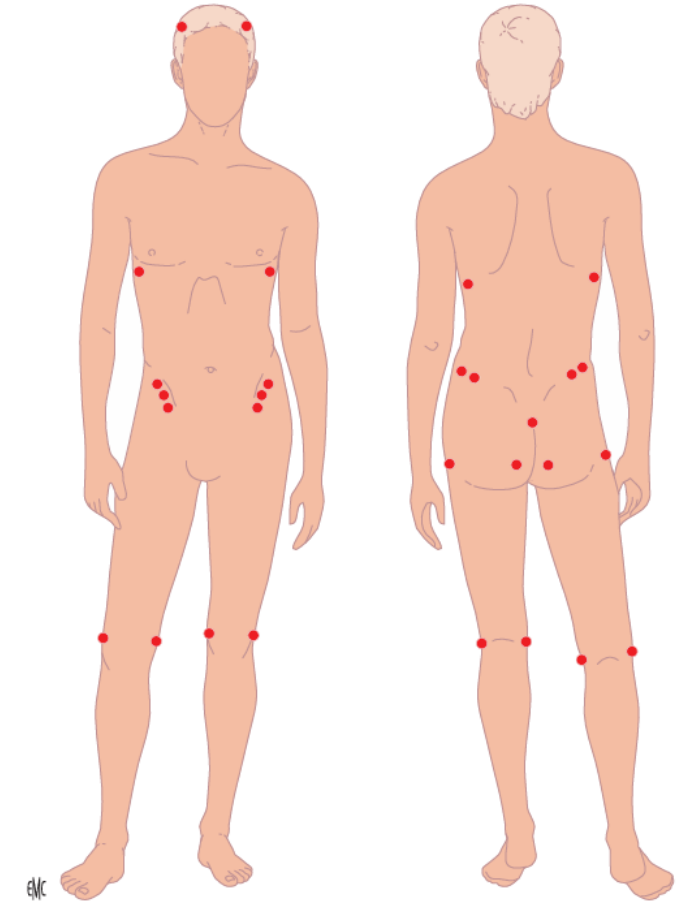


CLINIQUE

L'onchocercose souvent **asymptomatique** ou s'exprime par trois syndromes :

- **LE SYNDROME KYSTIQUE :**

Onchocercomes, ou nodules onchocerquiens, indolores au regard des os.



CLINIQUE

L'onchocercose souvent **asymptomatique** ou s'exprime par trois syndromes :

- **LE SYNDROME CUTANÉ :**

Lésions cutanées avec prurit, pachydermie, « gale filarienne », dépigmentation



Gale filarienne



Pseudo vitiligo onchocerquien (peau de léopard)



Sowda

CLINIQUE

L'onchocercose souvent **asymptomatique** ou s'exprime par trois syndromes :

- **LE SYNDROME OCULAIRE :**

Des lésions oculaires se manifestent après 10 à 15 ans d'évolution et sont dues à l'accumulation des **microfilaries** dans les yeux. Elles entraînent une **cécité totale**.



DIAGNOSTIC AU LABO

Diagnostic d'orientation: - Notion de séjour en région d'endémie - Hyperéosinophilie.

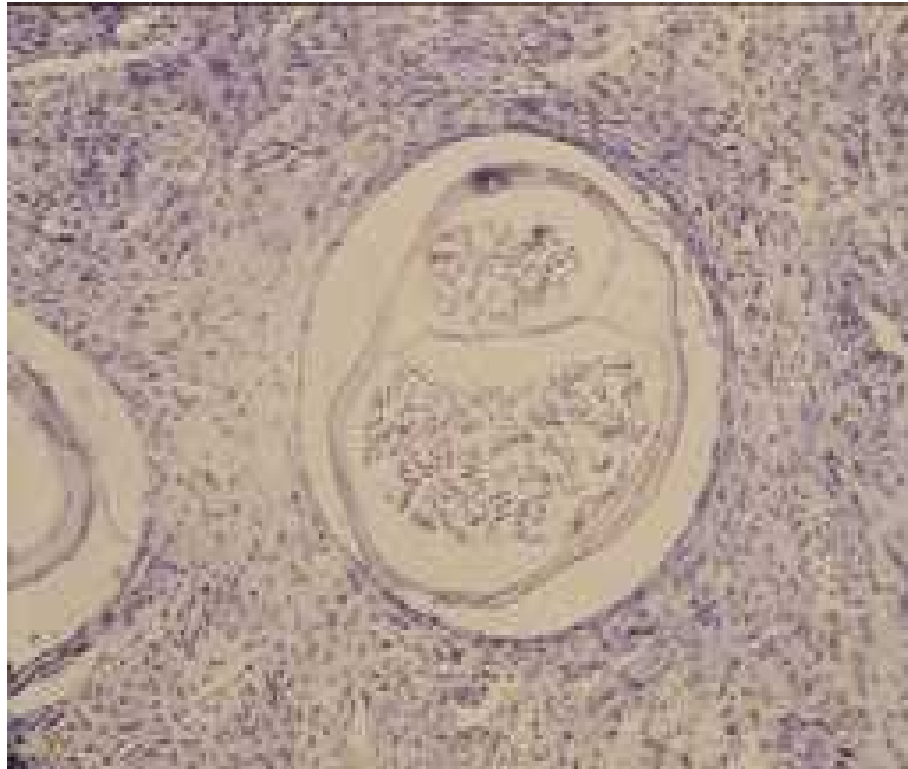
Diagnostic de certitude: la mise en évidence du parasite adulte ou de ses embryons

- La mise en évidence des **microfilaires** dans le derme, par:
 - scarification et examen du suc dermique,
 - Biopsie cutanée exsangue :précisant la « charge microfilarienne »

La présence de **microfilaires** dans les urines et parfois dans le sang a été signalée, surtout à la suite de traitements spécifiques.

- la ponction d'un nodule peut ramener un liquide contenant des **microfilaires**.
- Après nodulectomie, les **filaires adultes** sont facilement reconnaissables
- L'analyse histologique des onchocercomes permet de voir les **macrofilaires adultes**.
- L'examen ophtalmologique permet d'observer les microfilaires dans la chambre antérieure de l'œil.

Diagnostic indirect: repose sur la recherche d'anticorps sériques par ELISA ou par IFI.



Coupe anatomopathologique d'un nodule onchocerquien (adultes)



Recherche de microfilaries dans une biopsie cutanée exsangue

TRAITEMENT ET PROPHYLAXIE

Il est dirigé contre les **microfilaires** responsables des troubles cutanés et des lésions oculaires et plus difficilement contre les **filaires adultes**

- **Ivermectine:** (Traitement de choix) en prise unique

Action sur la jonction neuromusculaire des parasites, diminue la production des larves par les femelles.

L'OMS recommande de traiter l'onchocercose par l'ivermectine au moins une fois par an pendant 10 à 15 ans.

- L'**ivermectine** associée à l'**albendazole** aurait une action sur les filaires **adultes** en cure unique particulièrement intéressante en campagne de masse.
- Autres: **la diéthylcarbamazine**

L'incidence socio-économique et le nombre élevé de malades aveugles ont depuis les années 1970 motivé d'importantes enquêtes et campagnes de masse :

« Onchocerciasis Control Program », « African Program Onchocerciasis Control » ...

Loase à *Loa loa*

DEFINITION

La filariose à **Loa loa** (loase, ou loaose) est une helminthiase, cutanée par la localisation des vers adultes, et sanguicole par celle des embryons ou microfilaires.

Elle est strictement africaine et transmise par un taon appartenant au genre **Chrysops**.

Habituellement bénigne avec certains signes cliniques spectaculaires , mais peut évoluer occasionnellement vers des complications viscérales.

plus de 10 millions de personnes sont infestées en Afrique centrale.

ÉPIDÉMIOLOGIE

2- Morphologie et biologie

- ☐ Les adultes sont des vers blanchâtres, mesurent 2 à 7 cm de long, vivant sous la peau.
- ☐ La durée de vie du ver adulte est d'environ 10 à 15 ans.
- ☐ Les microfilaires (300 um), porteurs d'une gaine difficilement colorée par le Giemsa, vivant dans le sang périphérique.
- ☐ Microfilarémie de périodicité diurne.



Loa loa –microfilaires-



Loa loa -macrofilaires (adulte)-



ÉPIDÉMIOLOGIE



3- Vecteur:

Le vecteur est un un diptère de la famille des **Tabanidae** appartenant au genre **Chrysops** ou **mouche rouge**.

- Seules les femelles sont hématophages.
- Leur piqure est diurne et douloureuse.
- Il est strictement africain.

ÉPIDÉMIOLOGIE

4- Cycle évolutif: indirect

Homme: hôte définitif / Chrysops femelle: hôte intermédiaire.

Les microfilaires sont absorbées lors de la piqûre du Chrysops d'un sujet infecté. Elles évoluent en larves L1 puis en larve L2 dans les muscles thoraciques puis en larve L3 avant de migrer vers le labium.

Ces larves sont déposées sur la peau d'un sujet sain puis vont pénétrer activement par la blessure causée par la piqûre. Elles migrent sous la peau, deviennent adultes en **3 mois**.

les femelles pondent des microfilaires qui gagnent les capillaires périphériques et elles seront absorbées lors d'une piqûre ultérieure.

Indirect

Homme: hôte définitif

Chrysops femelle: hôte intermédiaire.

Chez l'insecte:

Les microfilaires sont absorbées lors de la piqûre du Chrysops d'un sujet infecté. Elles évoluent en larves L1 puis en larve L2 dans les muscles thoraciques puis en larve L3 avant de migrer vers la tête.

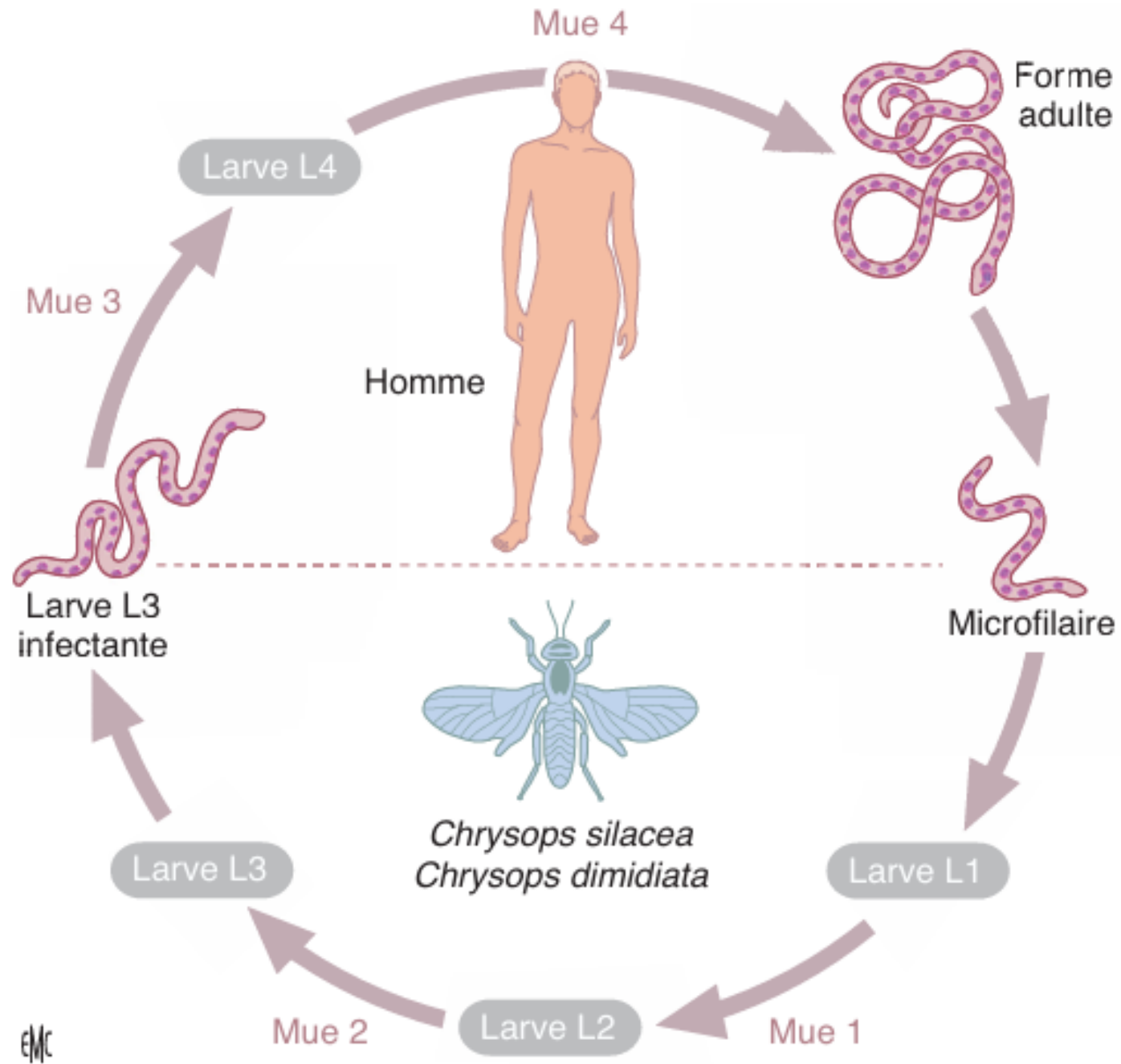


Figure 6. Cycle parasitaire de *Loa loa*.

Indirect

Homme: hôte définitif

Chrysops femelle: hôte intermédiaire.

Chez l'homme:

Ces larves sont déposées sur la peau d'un sujet sain puis vont pénétrer activement par la blessure causée par la piqûre. Elles migrent sous la peau, deviennent adultes en **3 mois**. Les femelles pondent des microfaires qui gagnent les capillaires périphériques et elles seront absorbées lors d'une piqûre ultérieure.

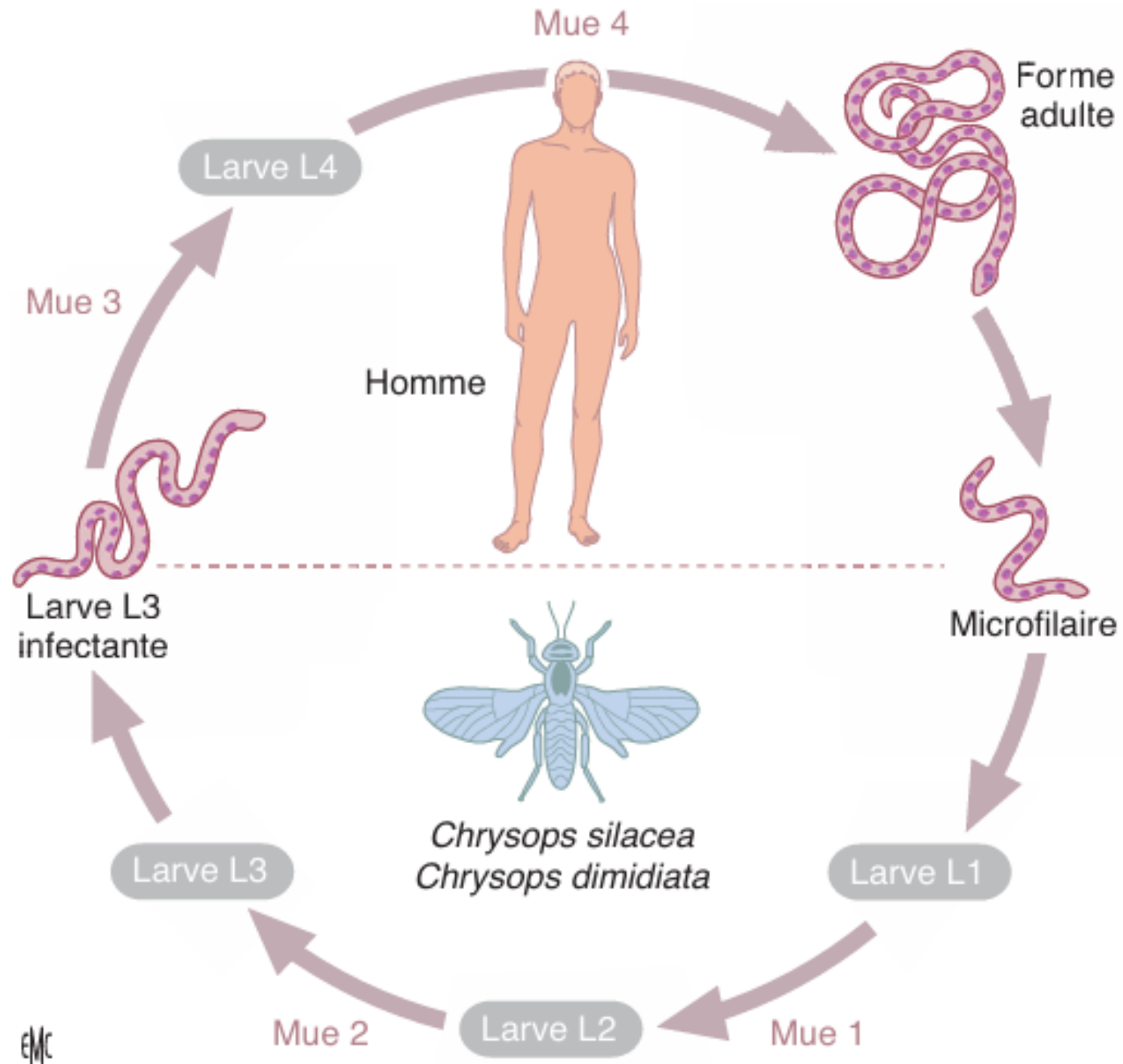


Figure 6. Cycle parasitaire de *Loa loa*.

ÉPIDÉMIOLOGIE

5- Répartition géographiques:

La loase est **strictement africaine**, surtout équatoriale et occidentale, limitée à la grande forêt.



Afrique centrale de l'ouest

CLINIQUE

- **Incubation: (3 mois)** silencieuse, s'accompagnant d'une hyperéosinophilie.
- Trois symptômes peuvent survenir : sporadiques, isolés ou groupés:
 1. **Le signe pathognomonique** est l'**œdème de Calabar** localisé surtout à la face ou aux membres supérieurs. Il est éphémère, migrateur et allergique.
 2. **La reptation du ver sous la peau** sous forme d'un cordon palpable, mobile, se déplaçant de **1cm/min**, entraînant un prurit, un fourmillement et un abcès en cas de la mort du ver.
 3. **Le passage du ver adulte sous la conjonctive**: bénin et fréquent, provoquant une photophobie avec des larmoiements et une gêne de la vision.
- **Complications:**

Neurologiques (hémiplégie, encéphalite), cardiaques (insuffisance cardiaque, endocardite) et rénales (protéinurie).



DIAGNOSTIC AU LABO

Diagnostic d'orientation

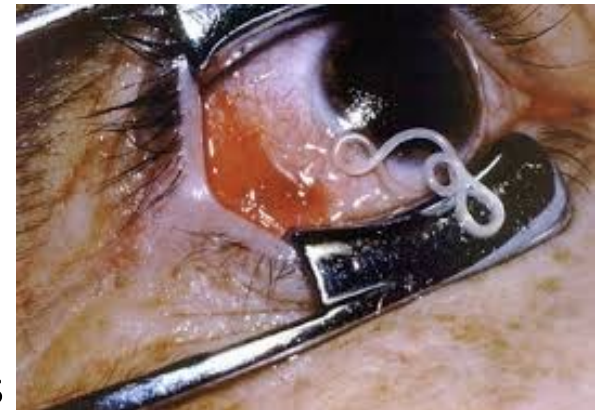
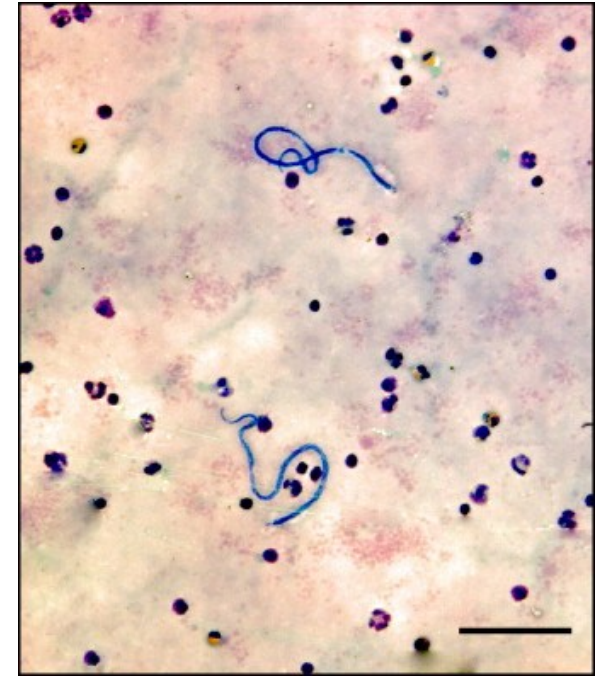
- Notion de séjour en région d'endémie – Hyperéosinophilie +++ - des œdèmes récidivants

Diagnostic de certitude:

- **La mise en évidence des microfilaries** dans le sang à l'état frais ou après coloration d'un frottis mince ou d'une goutte épaisse ou bien dans le culot d'une leucoconcentration (en cas de pauciparasitisme).
- Le prélèvement doit être effectué de jour entre **10 h et 16 h**. périodicité diurne
- Une numération des microfilaries est indispensable avant le traitement.
- **La mise en évidence de la macrofilarie** repérée lors de son passage sous les téguments ou lors de son cheminement sous-conjonctival. Son extraction se fait à l'aide d'un vaccinostyle, d'une pince fine ou après scarification.

Diagnostic indirect:

La recherche d'anticorps est indiquée chez les sujets présentant des manifestations cliniques évocatrices sans microfilarémie



TRAITEMENT

Le traitement de la loase est dangereux (risque d'effets indésirables, parfois mortels) et doit être conduit en milieu hospitalier spécialisé

- Il repose sur la **diéthylcarbamazine, ou Notézine®**.
à doses très progressivement croissantes accompagnées d'**antihistaminiques** ou de **corticoïdes**.
- L'**Ivermectine (Mectizan®)** utilisée en cure unique annuelle
(excellent microfilaricide , mais peu actif sur les adultes).
- L'exsanguinotransfusion ou, mieux, l'aphérèse constituent des alternatives thérapeutiques d'exception (microfilérémie > 30 000/ml).

Prophylaxie

La prophylaxie consiste à éviter les piqûres du taon par le port de vêtements longs car la lutte contre ces insectes est difficile (gîtes larvaires inaccessibles, insecticides souvent inefficaces).

En zone d'endémie, il peut être conseillé de prendre un demi-comprimé deux fois par semaine de **diéthylcarbamazine** 300 mg/semaine (résident temporaire mais inutile chez l'autochtone)

PAS DE TRAITEMENT DE MASSE (n'est pas incluse dans les MTN, pas de programme de lutte de l'OMS)

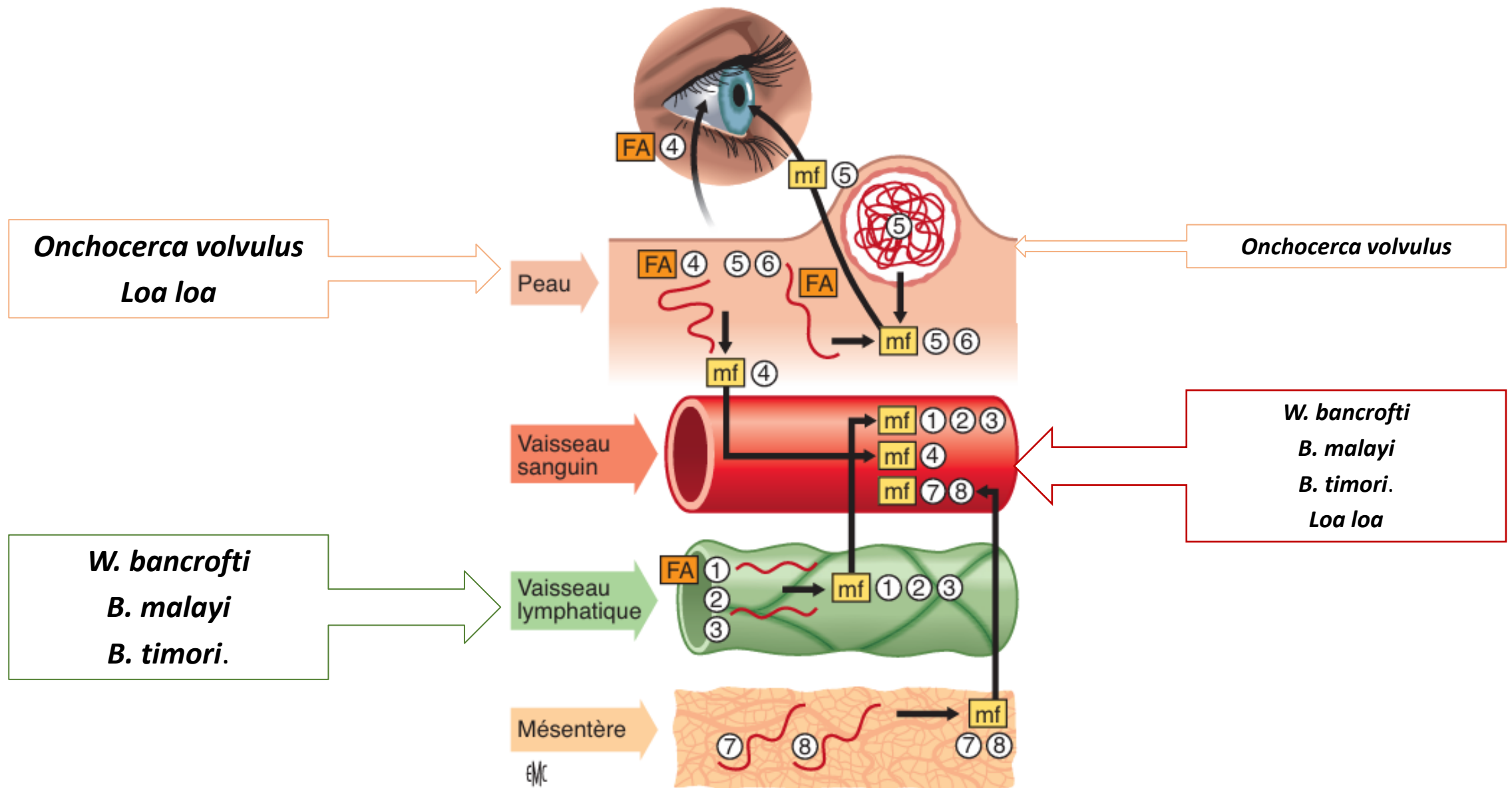


Figure 1. Classification des filaires selon la localisation des adultes (FA) et des microfilaries (mf). La classification (1 à 8) est décrite dans le Tableau 1. 1. *Wuchereria bancrofti* (Wb); 2. *Brugia malayi* (Bm); 3. *Brugia timori*; 4. *Loa loa*; 5. *Onchocerca volvulus* (Ov); 6. *Mansonella streptocerca* (Ms); 7. *Mansonella perstans* (Mp); 8. *Mansonella ozzardi* (Mo).

Filariose	Parasite(s)	Vecteurs	Localisation des adultes	Localisation des microfilaires	Stade pathogène	Distribution géographique
Onchocercose	<i>Onchocerca volvulus</i>	<i>Simulium damnosum</i> , <i>S. neavei</i> , <i>S. guianense</i>	Nodules sous-cutanés ou profonds	Derme, tissus oculaires	Microfilaires	Afrique intertropicale, Yémen, frontière Brésil-Venezuela
Loase	<i>Loa loa</i>	<i>Chrysops dimidiata</i> , <i>C. silacea</i>	Fascias, tissus sous-cutanés	Sang	Adultes, microfilaires	Afrique centrale (du Bénin au Soudan du Sud, du Tchad à l'Angola)
Filarioses lymphatiques	<i>Wuchereria bancrofti</i>	<i>Anopheles</i> sp., <i>Culex</i> sp., <i>Aedes</i> sp., <i>Mansonia</i> sp.	Vaisseaux et ganglions lymphatiques	Sang	Adultes, microfilaires ^a	Inde, Asie du Sud-Est, Afrique intertropicale, Région de Recife au Brésil, Guyana, Haïti, îles du Pacifique ^b
	<i>Brugia malayi</i>	<i>Anopheles</i> sp., <i>Mansonia</i> sp.	Vaisseaux et ganglions lymphatiques	Sang	Adultes, microfilaires ^a	Indonésie, Malaisie, Philippines, Inde
	<i>Brugia timori</i>	<i>Anopheles barbirostris</i>	Vaisseaux et ganglions lymphatiques	Sang	Adultes, microfilaires ^a ?	Timor et Petites Îles de la Sonde (Indonésie)



MERCI DE VOTRE ATTENTION